DEFINIÇÕES CLÍNICAS

1. Estado clínico basal - Se refere à condição de saúde e funcionalidade do paciente antes de uma doença aguda ou internação hospitalar. Ou seja, é o ponto de partida a partir do qual quaisquer alterações no estado de saúde são medidas

2. Comorbidades compensadas e/ou descompensadas do paciente - As comorbidades referem-se a doenças ou condições médicas adicionais que ocorrem simultaneamente em um paciente com uma doença primária. Em resumo, a compensação indica estabilidade e controle da doença, enquanto a descompensação indica exacerbação ou piora da condição.

Comorbidades Compensadas

Uma comorbidade é considerada *compensada* quando a condição subjacente está sob controle eficaz por meio de tratamento (como medicamentos, dieta ou mudanças no estilo de vida) [2].

<u>Características:</u>

- ✓ Sintomas são mínimos ou inexistentes.
- ✓ Os parâmetros clínicos (como pressão arterial, níveis de açúcar no sangue ou função cardíaca) estão dentro de faixas-alvo saudáveis ou aceitáveis
- ✓ A condição não está causando danos adicionais significativos ou afetando negativamente a doença primária ou a qualidade de vida geral do paciente.

Exemplo: Um paciente com diabetes tipo 2 que mantém consistentemente os níveis de glicose no sangue dentro da faixa normal com medicação oral e dieta controlada

Comorbidades Descompensadas

Uma comorbidade é considerada *descompensada* quando a condição subjacente não está bem controlada, resultando em sintomas agravados, complicações ou deterioração do estado de saúde geral do paciente

<u>Características:</u>

- ✓ Sintomas evidentes e muitas vezes graves.
- ✓ Os parâmetros clínicos estão fora das faixas-alvo desejadas.
- ✓ A condição pode levar a crises de saúde agudas, hospitalização ou afetar negativamente o tratamento da doença primária

Exemplo: Um paciente com insuficiência cardíaca que apresenta falta de ar, inchaço significativo nas pernas e ganho de peso súbito devido à retenção de líquidos, indicando que o coração não está bombeando sangue eficientemente